

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp tại Bệnh viện Từ Dũ Cơ Sở 2
Ngày 03 tháng 04 năm 2026

Ngày 24 tháng 03 năm 2026, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện đã chủ trì buổi họp với ban điều hành, các khoa của Bệnh viện Từ Dũ Cơ Sở 2.

Sau khi các khoa phòng báo cáo tiến độ thực hiện và trao đổi, thảo luận với đại diện các khoa, ban điều hành, BS CKII Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện có kết luận, chỉ đạo thực hiện các công tác sau trước ngày 10.04.2026:

1. Giám đốc khen ngợi các việc đã triển khai trong tuần trước:

- Các mục tiêu đặt ra trong tuần bắt đầu có tiến bộ.
- Các ca mổ khó đã triển khai và thực hiện tuân thủ tốt an toàn phẫu thuật – thủ thuật.
- Các ca chuyển viện được kiểm soát, theo dõi chăm sóc tốt.
- HCQT triển khai tốt các hạng mục tại tầng trệt khu D (triển khai khoa Ngoại, Sản, Nhi)
- Về ngoại cảnh HCQT phối hợp tốt với Thanh niên xung phong, CNTT, đơn vị làm sạch đảm bảo bệnh viện an toàn, xanh – sạch – đẹp.

2. Đối với công tác Hành chính quản trị:

a. Phòng khám:

- Phòng Điện - Phục hồi chức năng:
- + HCQT trang bị màn nhựa, từng thanh lá để ngăn khí lạnh (giống ở tầng 1 khu N, CS1)

b. Nội trú:

- Xét nghiệm: HCQT + Điều dưỡng rà soát những bảng decal không dùng, lấy giấy trắng che lại những vị trí không sử dụng
- Tầng trệt khu D (Khu vực dời Ngoại – Sản – Nhi):
 - + HCQT rà soát không để các ổ điện ngoài hành lang
 - + HCQT coi lại các đường ron trắng (giữa các gạch lát)
 - + HCQT lên kế hoạch xây dựng các cửa chính, cửa sổ hướng ra khu vực công viên (trưng tự khoa Sản – tầng trệt)
- HCQT trang bị Xquang thêm chuông gọi

3. Đối với công tác chuyên môn:

a. Công tác kiểm tra, giám sát:

- KHTH + TCCB xây dựng KPI đánh giá bác sĩ hiệu suất phòng khám:
 - + Số lượng thủ thuật trong ngày (40 ca thủ thuật PHCN/ ngày ; 40 ca thủ thuật YHCT / ngày)
 - + Số lượng ca trong ngày làm.
 - + Số lượng bệnh tái khám; số lượng bệnh chuyển viện, chuyển khám chuyên khoa qua lại tái khám.
 - + Số lượng bệnh được hẹn tái khám.
 - + Số lượng bệnh cho chỉ định khám đa chuyên khoa: 30% tổng số khám
 - + Số lượng bệnh chuyển viện/ chuyển khám chuyên khoa.

- KHTH + TCCB xây dựng KPI đánh giá hiệu suất XN (hiện tại quá tải 100 mẫu/ngày, không tải được 150 mẫu/ngày): 150 mẫu/ngày
- QLCL triển khai và có KH định kỳ hàng tuần đi khảo sát (Go See) và có báo cáo BGĐ tại CS2. Phối hợp KHTH + Điều dưỡng khảo sát hài lòng khách hàng và xây dựng các quy trình vận hành và chuyên môn sát thực tế ở CS2.
- KHTH rà soát 100% bệnh nhân GMHS phải đầy đủ biên bản hội chẩn đúng quy định, trong đó phải có BB Hội chẩn với GMHS CS1.

b. Công tác khám và điều trị:

- KHTH triển khai khám YHCT và PHCN trong người bệnh nội trú: Khoa LS mời BS PHCN, YHCT khám, đánh giá/ chỉ định tập (tập tại phòng tập khoa Khám). Lưu ý: đảm bảo chẩn đoán để thanh toán BHYT, TH không đủ điều kiện TT tư vấn NB tự chi trả.

- Phòng khám Nhi: KHTH triển khai và báo cáo:

- + Triển khai Phục Hồi chức năng cho bệnh nhi
- + Triển khai khám định kỳ + lịch hẹn tái khám cho đến 72 tháng.
- + Triển khai việc xây dựng cá thể hóa kế hoạch khám và điều trị cho từng bệnh

Nhi + triển khai tư vấn tiêm ngừa cho trẻ em

- + Triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn diện (hẹn tái khám).
- + KHTH + CNTT + Điều dưỡng (CSKH) triển khai hẹn nhắc tái khám định kỳ tháng/quý (lưu ý nhắc hẹn các phương tiện người dân thường xuyên sử dụng như kênh Zalo).

- Nội soi tiêu hóa:

+ KHTH trình chi tiết nội dung nội soi can thiệp. Trình BGĐ BV LVT và TD để thông qua.

- + KHTH báo cáo triển khai các vấn đề hành chính đúng quy định.
- + KHTH + QLCL xây dựng quy trình nội soi áp dụng tại CS2
- + KHTH triển khai hẹn khám Nội soi 2 lần/tuần (thứ 3/ thứ 5)
- + Triển khai thí điểm 2-3 ca nội soi /ngày
- + KHTH gửi công văn học tập Nội Soi tiêu hóa và TMH ở bệnh viện Bình Dân.

Sau đó, KHTH tổng hợp báo cáo (BV LVT và BV Bình Dân) những nội dung phù hợp để triển khai, cải tiến ở bệnh viện CS2, đảm bảo an toàn, đúng, đủ, hiệu quả.

- Khoa Cấp cứu: KHTH + Điều dưỡng xem quy chế và quy định sau bao lâu bệnh nhân có lác tay, đồng phục nhập viện tại cấp cứu.

- Giảm đau sản khoa: KHTH + TCKT báo cáo triển khai tăng số lượng giảm đau sản khoa ở CS2 trên 70%, lưu ý vấn đề thanh toán BHYT.

c. Bảo hiểm y tế:

- TCCB thành lập tổ BHYT CS2. Ra quyết định 01 nhân sự chịu trách nhiệm BHYT CS2.

d. Công tác báo cáo:

- KHTH + HCQT liên hệ CC115 báo cáo số liệu cho khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu tổng hợp số liệu báo cáo trên giao ban CS1 hằng ngày.
- KHTH phân tích mô hình chuyển viện/chuyển khám chuyên khoa. Tìm hiểu lý do bệnh viện nào được chuyển nhiều nhất.

- KHTH báo cáo giao ban chi tiết số lượt khám chuyên khoa được từng phòng khám chuyên.

e. Công tác chỉ đạo tuyến:

- Phối hợp với bệnh viện Nguyễn Tri Phương:

+ Bs. Trưởng khoa CC trao đổi với GD BV LVT về mô hình hợp tác với BV Nguyễn Tri Phương trong phối hợp điều trị Nội.

+ TCCB + KHTH gửi công văn bệnh viện Nguyễn Tri Phương về hợp tác trong điều trị bệnh nhân Nội, có thể 1 tuần từ 2-3 ngày (những ngày đông bệnh) tại CS2.

g. Tập huấn diễn tập:

- Báo cáo công tác diễn tập hàng tuần.

- KHTH trình KH tập huấn diễn tập hàng loạt theo tuần/ tháng/ quý trong đó bắt buộc có sự phối hợp diễn tập với TTYT của 4 xã, đơn vị CC115, BV LVT, và có tham gia giám sát online từ CS1. KHTH gửi công văn thông báo nội dung diễn tập và mời SYT tham gia giám sát online.

4. Đối với công tác quản lý khác:

a. Công tác điều phối bệnh:

- Triển khai khu G tầng trệt Nội trú vào thứ 6 tuần sau (10.04.2026)

- Nhà thuốc: HS in toa thuốc tập trung đồng thời hướng dẫn và tư vấn dùng thuốc

- Phòng Điện - Phục hồi chức năng: bộ phận hành chính hỗ trợ công tác hành chính.

- Bộ phận điều dưỡng rà soát nhân sự chăm sóc khách hàng mặc đồng phục đúng quy định

- CSKH điều phối hỗ trợ kịp thời bệnh nhân xe lăn.

b. Công tác quản lý khác:

- TCCB + KHTH + Điều Dưỡng + HCQT chuẩn bị nhân sự nghỉ lễ.

- TCCB rà soát báo cáo công tác điều phối lịch trực/ ra trực của BS khám bệnh. Trình bày tính khả thi.

- HCQT tiếp tục thực hành tiết kiệm.

- Bộ phận điều hành tăng cường phối hợp, giao lưu giữa Bảo vệ BV và TNXP.

- Nhân sự đơn vị làm sạch: TCCB + HCQT + Điều Dưỡng rà soát, báo cáo số lượng, vị trí nhân sự của đơn vị làm sạch phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả ở CS2.

- HCQT + Điều dưỡng + TCCB triển khai phòng nghỉ nhân viên đúng chuẩn, đúng quy định.

- BS. Lan Hương (TCCB), CN Nhân (Phòng TCKT) lên KH tìm kiếm khách hàng khám đoàn ở CS2, đối tượng: cơ sở giáo dục, thanh niên xung phong, các ban ngành đoàn thể, các cơ sở y tế, các cơ quan chính quyền địa phương.

- Điều dưỡng + KHTH tăng cường TTGDSK “Nuôi con bằng sữa loài người” (Human milk). 100% trẻ sinh tại CS2 được truyền thông, hướng dẫn về Nuôi con bằng sữa loài người.

- Cấp cứu 115: HCQT liên hệ với CC115 các nội dung cần có tại khu vực làm việc CC115 ở Khoa Cấp cứu: ghi rõ thông tin người trực, thông tin liên hệ. KHTH + TCCB + HCQT soạn thảo quy chế phối hợp hoạt động với CC115.

- Khoa Cấp cứu: KHTH + Điều dưỡng + HCQT rà soát chỉnh sửa bảng thông tin tại phòng họp Cấp cứu:

- + Bệnh nặng theo dõi toàn viện từng khoa theo ngày
 - + Số lượng người bệnh toàn viện từng khoa theo ngày
 - + Số lượng nhân viên toàn viện từng khoa theo ngày
 - KHTH + TCCB báo cáo nội dung nhà đại thể CS2 , lưu ý các vấn đề pháp lý. KHTH + TCCB trao đổi kinh nghiệm với BV LVT và BV Nguyễn Tri Phương.
- Phòng KHTH thông báo Kết luận của Giám đốc đề các khoa phòng liên quan để biết và nghiêm túc thực hiện.

GIÁM ĐỐC



BS CKII Trần Ngọc Hải